

Hasta Durum ve Gidişat Raporu

Klinik Takip Uygulaması — Kapsamlı Klinik Analiz

Ad Soyad	Alaattin Sönmez	Cinsiyet	Erkek
Doğum Tarihi	1 Ocak 1962 (64 yaşında)	Doğum Yeri	HATAY
İkamet	DEFNE / HATAY	Sigorta	SSK
Boy	174 cm	T.C. Kimlik No	gizlenmiştir
Ana Tanı	Tip A Aort Diseksiyonu	Cerrahi	Bentall Prosedürü (20 Şub 2026)
Protez	25mm Carbomedics mekanik kapak + 32mm Dacron greft	Veri Aralığı	19 Şub – 9 Eyl 2026 (~6,6 ay)

Güncel Durum Özeti (9 Eylül 2026)

Parametre	Değer	Not
Son Tansiyon (Eylül ort.)	111.2/75.7 mmHg	Hedef: <120/80 mmHg
Güncel Kilo	78.9 kg	Son 49 günde stabil
Son INR	2.72	Hedef: 2,0–3,0 (mekanik kapak)
Son Hemoglobin	9.7 g/dL	Referans: 13.5000–17.5000 (DÜŞÜK)
Son CRP	11.3 mg/L	Referans: 0–5.0000 (YÜKSEK, zirve 154)
Toplam Tansiyon Ölçümü	487	7 aylık ev takibi
Şiddetli HT Atağı	5	Sistolik ≥ 150 / Diyastolik ≥ 100
Yatış Sayısı	3	Bentall + 2× postop komplikasyon

1. Yönetici Özeti

Sistem Tarafından Üretilen Klinik Değerlendirme

KLİNİK DEĞERLENDİRME RAPORU (19.02.2026 - 09.09.2026)

1. TANSİYON TRENDİ:

19.02.2026 - 09.09.2026 tarihleri arasında toplam 488 adet tansiyon ölçümü yapılmıştır. Dönem ortalaması 122/81 mmHg olarak hesaplanmıştır ve bu genel olarak "~HT" kategorisindedir.

2. KİLO VE SIVI DURUMU:

Seçilen dönem sonu itibarıyla güncel kilo 78.8 kg'dır. Dönem başına (78.7 kg) göre 0.1 kg'lık bir artış gözlemlenmiştir.

3. LABORATUVAR ANALİZLERİ:

09.09.2026 tarihi ve öncesindeki son laboratuvar verilerine göre kritik parametre durumları şu şekildedir: INR: 2.72 (Bir önceki 25.08.2026 tarihindeki ölçüme göre: -0.04), HGB: 9.7 (Bir önceki 02.09.2026 tarihindeki ölçüme göre: +0.20), WBC: 7.97 (Bir önceki 02.09.2026 tarihindeki ölçüme göre: -1.99), CRP: 11.3 (Bir önceki 02.09.2026 tarihindeki ölçüme göre: -12.50). Bu dönemde referans aralığı dışında kalan parametreler: CHOL (Yüksek), CRP (Yüksek), FERRITIN (Düşük), HCT (Düşük), HDL (Düşük), HGB (Düşük), IRON (Düşük), LDL (Yüksek), MCH (Düşük), MCV (Düşük), RBC (Düşük), RDW-CV (Yüksek), RDW-SD (Yüksek).

4. İLAÇ TEDAVİSİ:

Seçilen dönemde aktif bir ilaç veya tedavi değişim kaydı bulunmamaktadır.

64 yaşındaki erkek hasta, 19 Şubat 2026 tarihinde ani başlayan yırtıcı karakterde göğüs ve sırt ağrısı ile acil servise başvurmuş; aynı gün içinde üç farklı merkeze sevk zinciriyle Tip A Aort Diseksiyonu ve 5,3 cm'lik asendan aort anevrizması + ciddi aort kapak yetmezliği tanısı kesinleştirilerek, tanıdan yaklaşık 10 saat sonra acil Bentall prosedürü (aort kökü + kapak + koroner buton replantasyonu) ile ameliyat edilmiştir. Ameliyat başarılı geçmiş ve hasta 10 gün sonra şifa ile taburcu edilmiştir.

Ameliyat sonrası 6,6 aylık izlem sürecinde hasta iki kez daha hastaneye yatırılmıştır: Mart sonunda şiddetli kabızlık ve bulantı-kusma nedeniyle genel cerrahi yatışı; Temmuz sonunda sternal insizyon bölgesinde dikiş ayrılması

(dehissens) ve ağır yara enfeksiyonu nedeniyle kardiyovasküler cerrahi yatışı. Nisan ayında evde üç kez şiddetli hipertansif atak (en yükseği 168/103 mmHg) yaşanmış, sublingual kaptopril ile kontrol altına alınmıştır.

Rapor tarihi itibarıyla hasta ayaktan izlemindedir; INR değeri (2,72) mekanik kapak için hedeflenen terapötik aralıkta, tansiyon ortalaması hedefe yakındır. Ancak kronik, mikrositer karakterde anemi (Hb 9,7 g/dL, düşük ferritin/demir), hafif düzeyde süregelen enflamasyon (CRP 11,3 mg/L) ve enfeksiyon şüphesiyle 4 Eylül'de yeniden başlanmış ampirik antibiyotik tedavisi dikkat çekmektedir. Lipid profilinde de kötüleşme (yüksek LDL/kolesterol, düşük HDL) izlenmektedir. Bu bulguların her biri Bölüm 8'de literatürle karşılaştırılmış, Bölüm 9'da ise hekimle görüşülmesi önerilen somut maddeler halinde özetlenmiştir.

2. Klinik Zaman Çizelgesi

Acil başvurudan güncel duruma kadar tüm kayıtlı klinik olaylar, kronolojik sırayla:

19 Şubat 2026, 17:21 · Defne Devlet Hastanesi [Acil Başvuru]

Hasta ani başlayan yırtıcı karakterde şiddetli göğüs ve sırt ağrısı ile ambulansla acil servise getirildi. İlk müdahale yapıldı, EKG, kardiyak troponin ve biyokimya testleri alındı. Hipertansif kriz ve diseksiyon şüphesiyle acil ileri merkeze sevki sağlandı.

19 Şubat 2026, 18:44 · Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi [Acil Başvuru]

Acil servise giriş yapıldı, hemogram paneli alındı. İntrakraniyal kanama ekartasyonu için acil Diffüzyon MRG (20:17) ve Kontrastsız Beyin BT (20:30) çekildi. Aktif kanama saptanmadı.

19 Şubat 2026, 21:41 · Kırıkhan Devlet Hastanesi [Acil Başvuru]

Kontrastlı Torasik ve Abdominal BT Anjiyografi çekildi. Aort kökünden iliak bifurkasyona dek uzanan Tip A Aort Diseksiyonu ve asendan aort anevrizması (5.3 cm) kesin tanısı kondu. Acil cerrahi için sevk edildi.

19 Şubat 2026, 23:22 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Kardiyovasküler Cerrahi servisine acil yatışı yapıldı. Ameliyat öncesi kapsamlı yoğun bakım hazırlık paneli ve crossmatch kan uyumu testleri tamamlandı.

20 Şubat 2026, 08:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Cerrahi Operasyon]

Derin hipotermik sirkülatuar arrest altında acil Bentall prosedürü uygulandı: 32mm Dacron asendan aort grefti ve 25mm Carbomedics mekanik aort kapak replasmanı yapıldı, koroner butonlar implante edildi.

2 Mart 2026, 09:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Taburcu]

Başarılı ameliyat ve yoğun bakım/servis süreci sonrası şifa ile taburcu edildi. Ömür boyu Warfarin kullanımı için rapor çıkarıldı. Günlük idame ilaçları (Dilatrend, EcopirinPro vs.) başlandı.

30 Mart 2026, 14:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Kabızlık ve bulantı/kusma şikayetleri nedeniyle yatış yapıldı; lavman uygulandı ve enfeksiyon parametreleri takip edildi (CRP: 101.4). Sternal yara enfeksiyonu takibine devam edildi.

31 Mart 2026, 14:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Taburcu]

Lavman sonrası gaz-gaita deşarjı sağlandı ve hasta şifa ile taburcu edildi.

16 Nisan 2026, 10:55 · Evde [Hipertansif Atak]

Kan basıncı 146/93 mmHg olarak ölçülmüş olup evde tansiyon takibi sıklaştırıldı.

17 Nisan 2026, 14:35 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon 156/97 mmHg'ye yükseldi. Acil antihipertansif olarak Kapril (25 mg) dilaltı alındı.

17 Nisan 2026, 23:39 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon 152/102 mmHg'ye yükseldi. Acil antihipertansif olarak Kapril (25 mg) dilaltı alındı.

18 Nisan 2026, 19:35 · Evde [Hipertansif Kriz]

Tansiyon tehlikeli seviyelere (168/103 mmHg) yükseldi; Kapril (25 mg) müdahalesi ile kriz kontrol altına alındı.

23 Temmuz 2026, 11:15 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi [Yatış]

Sternal insizyon bölgesinde dikişlerin açılması (dehissens), şiddetli enfeksiyon ve doku defekti nedeniyle KVC servisine yatırıldı. Kapsamlı

laboratuvar tahlili alındı. Çoklu s t r atıldı, beyaz kan transf zyonu uygulandı ve yoęun yara bakımı bařlatıldı.

28 Temmuz 2026, 11:15 ·  zel  skenderun Geliřim Hastanesi [Taburcu]

Taburcu oldu

3. İlk Bařvuru: D rt Hastaneli Sevk Zinciri

Tanının kesinleřmesine kadar geen ~6 saatlik s rete hasta   kez sevk edilmiřtir:

#	Merkez	Saat	Yapılan �řlemler
1	Defne Devlet Hastanesi	19 řubat 2026, 17:21	�lk acil bařvuru yapıldı. Ambulans ile getirilen hastanın EKG'si ekildi, kardiyak enzimleri (Troponin vb.) ve rutin biyokimyası alıřıldı. Hipertansif kriz tanısıyla ileri merkez sevk bařlatıldı.
2	Mustafa Kemal �niversitesi Hastanesi	19 řubat 2026, 18:44	N�rolojik kanama komplikasyonunu ekarte etmek iin acil Diff�zyon MRG ve Beyin BT ekildi. Kontrastlı madde �ncesi g�venlięi saęlandı.
3	Kırıkhan Devlet Hastanesi	19 řubat 2026, 21:41	Kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografi tamamlandı. 5.3 cm asendan aort anevrizması ve Tip A aort diseksiyonu kesin tanısı konularak acil cerrahiye sevk kararı alındı.
4	�zel �skenderun Geliřim Hastanesi	19 řubat 2026, 23:22	KVC ekibi tarafından ameliyata hazırlık iin acil yatıřı yapıldı. Crossmatch ve pre-op testleri tamamlanıp sabah erken saatte acil aık kalp ameliyatından ıktı.

Klinik not:

Bařvuruda saę kol

tansiyonunun sol
kola göre 40
mmHg düşük
ölçülmesi (kol-
arası TA farkı), Tip
A aort
diseksiyonunda
malperfüzyon/dal
tutulumu
açısından önemli
bir fizik muayene
bulgusudur ve
literatürde tanısal
şüpheyi
güçlendiren klasik
işaretlerden
biridir.

4. Cerrahi Müdahale: Bentall Prosedürü

20 Şubat 2026, saat 08:00 · Özel İskenderun Gelişim Hastanesi · Doç. Dr. Emre KUBAT (Kalp ve Damar Cerrahisi)

Yapılan Anatomik / Cerrahi Değişiklikler

- Dilate nativ asendan aort rezeke edildi (5.3 cm anevrizma); 32mm polyester Dacron vasküler greft ile replase edildi (değiştirildi).
- Yetersiz nativ aort kapağı, 25mm Carbomedics çift yapraklı metalik mekanik protez kalp kapağı ile replase edildi.
- Koroner arter butonları vasküler grefte implante edildi (Bentall Prosedürü 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlandı).
- Selektif antegrad serebral perfüzyon amacıyla sağ brakiyal arter ve sağ common karotid artere (CCA) cerrahi kanülasyon uygulandı; ardından primer vasküler onarım sağlandı.

Operasyon Notu (Epikriz Özeti)

Genel anestezi altında supin pozisyonndaki hastaya sağ brakiyal arter ve sağ ortak karotis arter (CCA) kanülasyonu uygulanmış; median sternotomi ile perikard açılmış, hemorajik mayi aspire edilmiştir. Belirgin dilate olan ve koaptasyonu bozulmuş aort kökü rezeke edilmiş; 32 mm Dacron greft, distalde hemiarkusu da içerecek şekilde anastomoz edilmiştir. Koroner butonlar hazırlanarak 25 mm Carbomedics metalik kapak-greft kompozitine implante edilmiş, dekanüle edilen brakiyal arter ve sağ CCA primer onarılmıştır.

Sonuç: Ameliyat
komplikasyonsuz
tamamlanmış,
hasta 2 Mart
2026'da
(ameliyattan 10
gün sonra) şifa ile
taburcu edilmiş;
ömür boyu
warfarin
kullanımı için
rapor
düzenlenmiştir.

3. Postoperatif Seyir ve Komplikasyonlar

Ameliyat sonrası 6,6 aylık dönemde kayıtlı üç ana komplikasyon süreci.

① Gastrointestinal Komplikasyon (30–31 Mart 2026)

Ameliyattan 40 gün sonra, 5 gündür defekasyon yapamama ve bulantı/kusma şikâyetiyle Genel Cerrahi servisine yatırılmıştır. Karın muayenesi rahat, defans/rebound negatif olarak değerlendirilmiş; lavman uygulaması sonrası gaz-gaita deşarjı sağlanarak ertesi gün şifa ile taburcu edilmiştir. Bu dönemde CRP 101,4 mg/L'ye kadar yükselmiş; aynı hafta (16 Mart) INR değeri 8,46'ya kadar yükselerek supratrapötik düzeye ulaşmış, warfarin dozunun düşürülmesiyle yönetilmiştir.

② Evde Hipertansif Ataklar (16–18 Nisan 2026)

Üç gün içinde art arda üç kez şiddetli kan basıncı yükselmesi kaydedilmiştir (146/93 → 156/97 → 152/102 → 168/103 mmHg). Her atakta sublingual Kapril (kaptopril 25 mg) ile akut kontrol sağlanmıştır. Kısa süre sonra (17 Nisan) BelocZOK kesilerek Dilatrend'e (karvedilol) geçilmiştir.

③ Sternal Yara Dehissensi ve Enfeksiyonu (23–28 Temmuz 2026)

Ameliyattan yaklaşık 5 ay sonra, sternal insizyon bölgesinde dikişlerin ayrılması (dehissens), doku defekti ve şiddetli enfeksiyon bulgularıyla KVC servisine tekrar yatırılmıştır. Çoklu sütür uygulanmış, yoğun yara bakımı başlatılmış; hemoglobinin 7,7 g/dL'ye gerilemesi nedeniyle kan/kan ürünü transfüzyonu uygulanmıştır. Beş günlük yatış sonrası şifa ile taburcu edilmiş; taburculuk sonrası Augmentin+Cipro ile oral antibiyoterapi 4 Ağustos'ta tamamlanmıştır.

Güncel gelişme: 4
Eylül 2026'da, CRP
yüksekliği
şüphesiyle yeniden
ampirik
antibiyotik
(Klamoks 1000mg,
günde 2×1)
başlanmış olup 7
günlük kür 10
Eylül'de
tamamlanacaktır.
Mart ayında alınan
yara kültüründe
üreme olmadığı
kayıtlıdır. Bu,
sternal enfeksiyon
sürecinin tam
sonlanmamış veya
nüksetmiş
olabileceğine
işaret edebilir (bkz.
Bölüm 9).

Şiddetli Hipertansif Ölçümler (Sistolik ≥ 150 veya Diyastolik ≥ 100 mmHg)

Tarih / Saat	Ölçüm
24 Mart 2026, 19:41	154/98 mmHg
17 Nisan 2026, 14:38	156/97 mmHg
17 Nisan 2026, 23:38	152/102 mmHg
18 Nisan 2026, 19:34	168/103 mmHg
31 Temmuz 2026, 21:18	149/101 mmHg

7 aylık dönemde toplam 487 tansiyon ölçümünden yalnızca 5 tanesi bu eşiği aşmıştır — genel olarak iyi kontrollü bir seyir olduğunu göstermektedir.

4. Güncel İlaç Tedavisi

9 Eylül 2026 itibarıyla aktif olan 6 düzenli tedavi ve 1 adet gerektiğinde kullanılan (PRN) ilaç:

İlaç	Sınıf	Doz	Kullanım	Not
Panto	Mide Koruyucu	40mg günde 1×1	Düzenli	Taburculuk sonrası devam edildi
Dilatrend	Beta Blokör	6.25mg günde 2×1	Düzenli	Taburculuk sonrası yeni doz ile devam edildi (Yükseltildi)
EcopirinPro	Antiplatelet	81mg günde 1×1	Düzenli	Taburculuk sonrası devam edildi
Coversyl	Antihipertansif	5mg günde 1×1	Düzenli	Doktor tarafından başlandı (ACE inhibitörü, kan basıncı regülasyonu)
Warfmadin	Antikoagülan	5mg haftalık	Düzenli	Doktor tarafından doz ayarlaması (INR takibine göre)
Klamoks	Antibiyotik	1000mg günde 2×1	Düzenli	4 Eylül'de başlanan 7 günlük ampirik kür; 10 Eylül'de

İlaç	Sınıf	Doz	Kullanım	Not
Kapril	Antihipertansif	25mg	PRN / Gerektiğind e	tamamlanacak. Acil durum tansiyon yüksekliği (168/103 mmHg)

Antikoagülasyon +
antiplatelet birlikte
kullanımı: Hasta
hem yaşam boyu
warfarin (mekanik
kapak nedeniyle)
hem de düşük doz
aspirin
(EcopirinPro 81mg)
kullanmaktadır.
Koroner butonların
cerrahi olarak greft
üzerine implante
edilmiş olması bu
kombinasyon için
klinik gerekçe
oluşturabilir; ancak
kanama riskini
artırdığından
dikkatli izlem
önemlidir.

Tüm İlaç Değişiklik Geçmişi (20 farklı ilaç, 66 kayıt)

İlaç	Sınıf	Tarih	İşlem	Gerekçe
Tavanic	Antibiyotik	8 Mart 2026, 09:11	Ended	Tedavi süresi tamamlandı (7 günlük kür)
Cordarone	Antiaritmik	12 Mart 2026, 12:36	Ended	Doktor tarafından sonlandırıldı (Ritim stabil)
GeralginePlu	Analjezik	29 Mart	Ended	Doktor tarafından

İlaç	Sınıf	Tarih	İşlem	Gerekçe
s		2026, 21:46		sonlandırıldı (Ağrı kontrolü tamamlandı)
Mikostatin	Antifungal	29 Mart 2026, 23:01	Ended	Doktor tarafından sonlandırıldı (Tedavi süresi tamamlandı)
Levopront	Antitussif	30 Mart 2026, 09:01	Ended	Doktor tarafından sonlandırıldı (Öksürük kesildi)
Stafine	Antibiyotik	5 Nisan 2026, 22:46	Ended	Tedavi süresi tamamlandı (7 günlük kür)
BelocZOK	Beta Blokör	17 Nisan 2026, 08:35	Ended	Doktor tarafından sonlandırıldı (Dilatrend'e geçildi)
Kapril	Antihipertansiyon	18 Nisan 2026, 19:35	Taken	Acil durum tansiyon yüksekliği (168/103 mmHg)
Apikobal	Vitamin	4 Mayıs 2026, 13:31	Ended	Doktor tarafından sonlandırıldı (B12 seviyesi normale döndü)
Coraspin	Antiplatelet	27 Temmuz 2026, 23:59	Ended	Taburculuk öncesi EcopirinPro'ya dönüş yapıldı
Sulcid	Antibiyotik	28 Temmuz 2026, 12:00	Ended	Taburculuk sonrası oral antibiyotik tedavisine (Augmentin + Cipro) geçildi
Panto	Mide Koruyucu	28 Temmuz 2026, 13:59	Resumed	Taburculuk sonrası devam edildi
Dilatrend	Beta Blokör	28 Temmuz 2026,	Resumed	Taburculuk sonrası yeni doz ile devam

İlaç	Sınıf	Tarih	İşlem	Gerekçe
		13:59		edildi (Yükseltildi)
EcopirinPro	Antiplatelet	28 Temmuz 2026, 13:59	Resumed	Taburculuk sonrası devam edildi
Oksapar	Antikoagülan	3 Ağustos 2026, 20:59	Ended	Warfmadin'e geçildi.
Coversyl	Antihipertansiyon	4 Ağustos 2026, 07:00	Started	Doktor tarafından başlandı (ACE inhibitörü, kan basıncı regülasyonu)
Cipro	Antibiyotik	4 Ağustos 2026, 09:45	Ended	Tedavi süresi tamamlandı (7 günlük kür)
Augmentin	Antibiyotik	4 Ağustos 2026, 09:45	Ended	Tedavi süresi tamamlandı (7 günlük kür)
Warfmadin	Antikoagülan	18 Ağustos 2026, 12:00	Changed	Doktor tarafından doz ayarlaması (INR takibine göre)
Klamoks	Antibiyotik	10 Eylül 2026, 20:59	Ended	7 günlük kür sonu

5. Vital Bulgu Trendleri

Ev takibinde kayıtlı 487 tansiyon ve 175 kilo ölçümünün aylık özetleri.

Kan Basıncı — Aylık Özet (mmHg)

Ay	Ölçüm	Ortalama	Min	Maks
Mart 2026	69	109.2/76.8	83/60	154/98
Nisan 2026	96	109.4/77.8	85/60	168/103
Mayıs 2026	63	118.6/80.2	100/68	140/95
Haziran 2026	68	127.2/84.6	109/72	149/99
Temmuz 2026	84	124.9/83.2	102/60	149/101
Ağustos 2026	89	118.7/79.9	99/65	139/95
Eylül 2026	18	111.2/75.7	103/68	122/82

Mart–Nisan aylarında ortalama sistolik ~109 mmHg iken, Haziran–Temmuz'da ortalama 125–127 mmHg'ye yükselmiş; Ağustos'ta Coversyl eklenmesinin ardından Eylül ayı ortalaması tekrar 111 mmHg'ye gerilemiştir. Genel eğilim olumludur ancak hedefin (<120 mmHg) zaman zaman üzerine çıkmaktadır.

Kilo — Aylık Özet

Ay	Ölçüm	Ortalama	Aralık
Mart 2026	25	81.2 kg	78.9 – 85.3 kg
Nisan 2026	30	76.3 kg	74.8 – 78.6 kg
Mayıs 2026	31	78.1 kg	75.8 – 80.2 kg
Haziran 2026	27	79.3 kg	78.4 – 80.7 kg
Temmuz 2026	26	78.4 kg	77.5 – 79.4 kg
Ağustos 2026	27	78.7 kg	77.9 – 80 kg
Eylül 2026	9	78.9 kg	78.5 – 79.4 kg

Ameliyat sonrası ilk haftalarda gözlenen kilo kaybı (85,3 → ~75 kg aralığı) sonrasında kilo Mayıs ayından itibaren 78–79 kg civarında stabilize olmuştur.

6. Laboratuvar Bulguları ve Trendler

19 Şubat – 8 Eylül 2026 arası, 90 test panelinde toplam 2.028 ayrı laboratuvar ölçümünden derlenen, klinik açıdan öncelikli parametrelerin özeti.

Koagülasyon (Antikoagülasyon Takibi)

Mekanik kalp kapağı nedeniyle ömür boyu izlenir. PT/aPTT warfarin nedeniyle beklenen şekilde uzamıştır; tek başına anormal sayılmaz. D-Dimer yalnızca tanı anında bir kez ölçülmüştür.

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min–Maks	n	Durum
INR (INR)	2,0–3,0 (tedavi hedefi) INR	1.1 (19 Şubat 2026)	2.72 (2 Eylül 2026)	1.1–8.46	38	TEDAVİ ARALIĞI NDA
Protrombin Zamanı (PT) (PT)	9.6000–12.0000 sn	13.1 (19 Şubat 2026)	24.6 (2 Eylül 2026)	11.9–64	38	ANTİKO AG. İLE TAKİP
aPTT (APTT)	23.9000–33.2000 sn	27.9 (19 Şubat 2026)	50.8 (2 Eylül 2026)	27.9–85.5	26	ANTİKO AG. İLE TAKİP
D-Dimer (Kantitatif) (D-DIMER)	0.0000–500.0000 ng/mL	5510 (19 Şubat 2026)	9656.4 (19 Şubat 2026)	5510–9656.4	2	YÜKSEK

Enflamasyon Belirteçleri

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min–Maks	n	Durum
C-Reaktif Protein (CRP) (CRP)	0.0000–5.0000 mg/L	2.6 (19 Şubat 2026)	11.3 (8 Eylül 2026)	2.6–154	23	YÜKSEK

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Sedimantasyon (ESR) (SEDIM)	0.0000–20.0000 mm/saat	61 (30 Mart 2026)	46 (5 Mayıs 2026)	46–61	2	YÜKSEK
Nötrofil / Lenfosit Oranı (NLR) (NLR)	— -	1.47 (15 Haziran 2026)	1.36 (8 Eylül 2026)	1–1.47	8	NORMAL

Hematoloji ve Anemi Paneli

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Hemoglobini (HGB) (HGB)	13.5000–17.5000 g/dL	14 (19 Şubat 2026)	9.7 (8 Eylül 2026)	7.7–14	31	DÜŞÜK
Hematokrit (HCT) (HCT)	40.0000–52.0000 %	41.4 (19 Şubat 2026)	29.7 (8 Eylül 2026)	25–41.4	32	DÜŞÜK
Eritrosit Sayısı (RBC) (RBC)	4.2000–6.2000 10 ¹² /L	4.63 (19 Şubat 2026)	3.89 (8 Eylül 2026)	2.73–4.63	31	DÜŞÜK
Trombosit Sayısı (PLT) (PLT)	150.0000–403.0000 10 ⁹ /L	163 (19 Şubat 2026)	365 (8 Eylül 2026)	88–489	31	NORMAL
Lökosit Sayısı (WBC) (WBC)	4.5000–11.0000 10 ⁹ /L	10.62 (19 Şubat 2026)	7.97 (8 Eylül 2026)	7.85–27.1	32	NORMAL
MCH (MCH)	27.0000–34.0000 pg	30.8 (19 Şubat 2026)	24.9 (8 Eylül 2026)	24.5–30.8	24	DÜŞÜK
MCV (MCV)	80.0000–	88 (19 Şubat 2026)	76.4 (8 Eylül 2026)	76.4–92.3	24	DÜŞÜK

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
	100.0000 fL	Şubat 2026)	Eylül 2026)			
MCHC (MCHC)	32.0000–36.0000 g/dL	35.1 (19 Şubat 2026)	32.7 (8 Eylül 2026)	30.1–35.1	24	NORMA L
Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW-CV) (RDW-CV)	10.0000–16.5000 %	13.9 (19 Şubat 2026)	17.8 (8 Eylül 2026)	13.9–20.2	23	YÜKSE K
Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW-SD) (RDW-SD)	37.0000–49.0000 fL	45.7 (19 Şubat 2026)	50.8 (8 Eylül 2026)	45.7–61.2	23	YÜKSE K
Ferritin (FERRITIN)	30.0000–400.0000 µg/L	19 (8 Eylül 2026)	19 (8 Eylül 2026)	19–19	1	DÜŞÜK
Demir (IRON)	59.0000–158.0000 µg/dL	15 (8 Eylül 2026)	15 (8 Eylül 2026)	15–15	1	DÜŞÜK
UIBC (UIBC)	110.0000–370.0000 µg/dL	326.8 (8 Eylül 2026)	326.8 (8 Eylül 2026)	326.8–326.8	1	NORMA L
Vitamin B12 (B12)	211.0000–946.0000 pg/mL	638 (8 Eylül 2026)	638 (8 Eylül 2026)	638–638	1	NORMA L
Folat (FOLATE)	3.1000–17.5000 ng/mL	4.76 (8 Eylül 2026)	4.76 (8 Eylül 2026)	4.76–4.76	1	NORMA L

Böbrek Fonksiyonu ve Elektrolitler

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Kreatinin (CREA)	0.6000–1.3000 mg/dL	1.11 (19 Şubat 2026)	1.02 (8 Eylül 2026)	0.76–1.13	25	NORMAL
Üre Azotu (BUN) (BUN)	7.0000–28.0000 mg/dL	18.3 (19 Şubat 2026)	11 (8 Eylül 2026)	9.2–29	25	NORMAL
t GFH (CKD-EPI formülü ile) (GFR_CKD_EPI)	— mL/dk/1.73 m ²	72.58 (20 Mart 2026)	75.58 (25 Ağustos 2026)	72.58–94	7	NORMAL
Sodyum (NA)	135.0000–145.0000 mmol/L	136 (19 Şubat 2026)	137 (8 Eylül 2026)	131–149	21	NORMAL
Potasyum (K)	3.5000–5.5000 mmol/L	3.64 (19 Şubat 2026)	4.65 (8 Eylül 2026)	3.44–4.88	21	NORMAL
Klor (CL)	98.0000–107.0000 mmol/L	103 (19 Şubat 2026)	103 (8 Eylül 2026)	94–104	10	NORMAL
Kalsiyum (CA)	8.8000–10.2000 mg/dL	8.66 (19 Şubat 2026)	9.09 (25 Ağustos 2026)	8.2–9.44	5	NORMAL
Fosfor (PHOS)	2.3000–3.7000 mg/dL	2.89 (8 Eylül 2026)	2.89 (8 Eylül 2026)	2.89–2.89	1	NORMAL
Magnezyum (MG)	1.5800–2.5500 mg/dL	1.81 (19 Şubat 2026)	2.02 (8 Eylül 2026)	1.81–2.02	4	NORMAL

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Albümin (ALB)	35.0000–52.0000 g/L	2026) 40 (19 Şubat 2026)	2026) 43 (25 Ağustos 2026)	33–43	6	NORMAL

Lipid Profili ve Glukoz Metabolizması

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Kolesterol (CHOL)	140.0000–200.0000 mg/dL	179 (19 Şubat 2026)	210 (8 Eylül 2026)	179–210	2	YÜKSEK
LDL Kolesterol (Direkt) (LDL)	60.0000–130.0000 mg/dL	119.6 (19 Şubat 2026)	141 (8 Eylül 2026)	119.6–141	2	YÜKSEK
HDL Kolesterol (HDL)	35.0000–75.0000 mg/dL	35.4 (19 Şubat 2026)	34 (8 Eylül 2026)	34–35.4	2	DÜŞÜK
Trigliserid (TRIG)	55.0000–200.0000 mg/dL	123 (19 Şubat 2026)	164 (8 Eylül 2026)	123–164	2	NORMAL
Glukoz (GLU)	80.0000–110.0000 mg/dL	81 (19 Şubat 2026)	102 (8 Eylül 2026)	81–146	21	NORMAL
HbA1c (%) (HBA1C)	4.8000–5.9000 %	5.3 (8 Eylül 2026)	5.3 (8 Eylül 2026)	5.3–5.3	1	NORMAL

Tiroid Fonksiyonu

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
TSH (TSH)	0.2700–4.2000 mIU/L	0.86 (19 Şubat 2026)	0.279 (8 Eylül 2026)	0.279–0.86	2	NORMAL

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Serbest T3 (FT3)	2.0000–4.4000 ng/L	2.99 (19 Şubat 2026)	2.58 (8 Eylül 2026)	2.58–2.99	2	NORMAL
Serbest T4 (FT4)	0.9300–1.7000 ng/dL	1.51 (19 Şubat 2026)	1.45 (8 Eylül 2026)	1.45–1.51	2	NORMAL

Karaciğer Fonksiyon Testleri

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Alanin Aminotransferaz (ALT)	5.0000–50.0000 U/L	19 (19 Şubat 2026)	14 (25 Ağustos 2026)	7–62	21	NORMAL
Aspartat Aminotransferaz (AST)	5.0000–46.0000 U/L	19 (19 Şubat 2026)	14 (25 Ağustos 2026)	13–84	21	NORMAL
Alkalen Fosfataz (ALP)	40.0000–129.0000 U/L	56 (19 Şubat 2026)	86 (25 Ağustos 2026)	56–95	4	NORMAL
Gamma Glutamil Transferaz (GGT)	7.0000–60.0000 U/L	15 (19 Şubat 2026)	15 (8 Eylül 2026)	15–41	3	NORMAL
Total Bilirubin (TBIL)	0.0000–1.0000 mg/dL	0.75 (19 Şubat 2026)	0.6 (25 Ağustos 2026)	0.6–1.35	11	NORMAL
Direkt Bilirubin (DBIL)	0.0000–0.3000 mg/dL	0.23 (19 Şubat 2026)	0.24 (8 Eylül 2026)	0.17–0.32	15	NORMAL
Laktat Dehidrogen	135.0000–225.0000 U/L	226 (19 Şubat 2026)	176 (8 Eylül 2026)	176–281	5	NORMAL

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
az (LDH) (LDH)		Şubat 2026)	2026)			

Kardiyak Enzim

Postoperatif miyokard hasarı ekartasyonu için.

Parametre	Referans	İlk Ölçüm	Son Ölçüm	Min-Maks	n	Durum
Troponin I (TROP-I)	0.0000– 45.0000 ng/L	17.76 (19 Şubat 2026)	10 (20 Mart 2026)	10–17.76	2	NORMA L

Dikkat çeken
örüntü —
mikrositer
anemi:
Hemoglobin
(9,7 g/dL),
hematokrit
(%29,7), ferritin
(19 µg/L) ve
serum demiri
(15 µg/dL)
referans
altında; MCV
zaman içinde
88'den 76,4
fL'ye gerilemiş,
RDW-CV
%13,9'dan
%17,8'e
yükselmiştir.
Bu örüntü
demir eksikliği
anemisi ile

uyumludur
(bkz. Bölüm 9).

9. Görüntüleme Bulguları — Kronolojik Özet

Tarih	Tetkik	Ana Bulgular	Sonuç
19 Şub 2026	Diffüzyon MRG (Beyin)	Akut infarkt/iskemi lehine kısıtlama yok.	Normal
19 Şub 2026	Acil Beyin BT	Kalvaryal fraktür veya kanama yok.	Normal
19 Şub 2026	Abdominal BT Anjiyografi	Asendan aorta 5,3 cm; diseksiyon flebi aort kökünden iliak bifurkasyona dek.	Tip A diseksiyon — batın içi uzanım
19 Şub 2026	Torasik Aorta BT Anjiyografi	Asendan aorta 5,3 cm; diseksiyon flebi aort kökünden iliak bifurkasyona dek.	Tip A Aort Diseksiyonu — tanı kesinleşti
20 Mar 2026	Akciğer Grafisi	Postoperatif kardiyomegali; aktif plevral efüzyon yok.	Beklenen postop görünüm
5 May 2026	Kontrol Abdominal BT Anjiyografi	Abdominal aorta suprarenal 38mm; diseksiyon flebi devam; safra taşı; bilateral böbrek kisti.	Stabil ektazi + insidental bulgular
5 May 2026	Kontrol Toraks BT Anjiyografi	Aort kökü 46mm, ark 46mm, inen aorta 39mm; perikardiyal efüzyon yok.	Operasyon loju stabil
17 Tem 2026	Acil Toraks BT (Kontrastsız)	Sternumda defekt; minimal perikardiyal efüzyon; fibrotik değişiklikler.	Akut şikayete yönelik — aort çapları ölçülmedi

Aort apı Seyri (mm)

Tarih	Aort Kk	Arkus	İnen Aorta	Abdominal (suprarenal)
19 Őub 2026 (tanı anı)	—	—	5,3 cm (asendan)	—
5 May 2026 (~10,6 hafta postop)	46 mm	46 mm	39 mm	38 mm

Takip grntleme aralıęı:

Ameliyattan bu yana geen sre ~6,6 ay olup, ilk kontrol BT anjiyografisi ameliyattan ~10,6 hafta sonra (5 Mayıs) yapılmıřtır. Bu tarihten itibaren 4 ay iinde planlı bir kontrol aort BT anjiyografisi kaydına rastlanmamıřtır; 17 Temmuz'daki tetkik kontrastsız olup aort aplarını yeniden lmemiřtir.

Kan Basıncı Sınıflandırması (ESC 2023 Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu): Aort cerrahisi ve rezidel diseksiyon hastalarında hedef kan basıncı <120/80 mmHg olarak nerilmekte; sistolik kan basıncındaki dP/dt kesme stresinin kontrol altına alınması esastır [Mancia et al., 2023].

Mekanik Kapak Sonrası Antikoagölasyon (2021 ESC/EACTS Valvüler Kalp Hastalığı Kılavuzu): Mekanik protez aort kapağı taşıyan hastalarda ömür boyu vitamin K antagonisti (Warfarin) ile INR 2.0-3.0 aralığında antikoagölasyon sınıf I endikasyondur [Vahanian et al., 2021].

7. Bilimsel Literatür ile Karşılaştırma

Aşağıda hastanın klinik seyrine ilişkin yedi ana başlık, güncel tıbbi literatür ve kılavuzlarla (kaynak numaraları Bölüm 12'de) karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir.

① Bentall Prosedürü Sonrası Sağkalım [Kaynak 1, 5, 9]

Güncel seriler, aort köküne sınırlı hastalıkta Bentall prosedürünün operatif mortalitesinin malperfüzyon olmayan hastalarda ~%5,7, malperfüzyon eşlik eden olgularda ~%21,5'e kadar çıkabildiğini göstermektedir. Geniş bir seride (1997–2023, 1.493 hasta) operasyonu atlatan hastaların uzun dönemli sağkalımının genel Bentall popülasyonuna benzer seyrettiği bildirilmiştir. Bu hastada ameliyat komplikasyonsuz tamamlanmış ve 10 gün içinde şifa ile taburcu edilmiştir — literatürdeki başarılı vaka seyriyle uyumludur.

② Mekanik Aort Kapağında Hedef INR Aralığı [Kaynak 2]

2020 ACC/AHA Kapak Hastalığı Kılavuzu, ek risk faktörü taşımayan bileaflet mekanik aort kapağı hastalarında INR hedefini 2,5 (pratikte ~2,0–3,0) olarak önermektedir; ek risk faktörü varlığında hedef 3,0'a çıkar. Hastanın son INR değeri (2,72) bu aralıktadır. Ancak 16 Mart'ta INR'nin 8,46'ya kadar yükseldiği, kanama açısından yüksek riskli bir supratherapötik dönem yaşanmıştır.

③ Warfarin + Aspirin Birlikte Kullanımı [Kaynak 2, 10]

Mekanik kapak hastalarında, ek bir endikasyon olmadıkça rutin aspirin eklenmesi sınırlı bir endikasyondur; kombinasyon tromboembolik olayları azaltmakla birlikte kanama riskini artırır. Bu hastada koroner butonların cerrahi olarak greft üzerine reimplante edilmiş olması aspirin eklenmesi için makul bir gerekçe oluşturabilir; EcopirinPro + Warfarin kombinasyonu kılavuzlarla uyumlu görünse de yakın izlem gerektirir.

④ Derin Sternal Yara Enfeksiyonu / Dehissens [Kaynak 3, 4]

Kardiyak cerrahi sonrası derin sternal yara enfeksiyonu sıklığı %0,5–3, dehissens sıklığı %0,4–5 aralığında bildirilmektedir. Risk faktörleri arasında diyabet,

obezite, KOAH, uzamış baypas süresi, reoperasyon ve transfüzyon sayılır. Bu hastada 23 Temmuz'da gelişen dehissens+enfeksiyon başarıyla yönetilmiş, ancak 4 Eylül'de CRP yüksekliği nedeniyle yeniden antibiyoterapi başlanması sürecin tam sonlanmamış olabileceğine işaret edebilir.

⑤ Aort Diseksiyonu Sonrası Kan Basıncı Hedefi [Kaynak 6, 7]

Aort diseksiyonu onarımı sonrası sistolik kan basıncını 120 mmHg altında tutmanın geç reoperasyon riskini belirgin azalttığı gösterilmiştir (SBP<120 grubunda 10–15 yıllık reoperasyonsuz sağkalım %92, SBP>140 grubunda %30–49). Hastanın dönemsel ortalama tansiyonu 111–127/75–85 mmHg aralığında olup, Haziran–Temmuz'da hedefin üzerinde seyretmiş, Ağustos'ta Coversyl eklenmesiyle Eylül'de tekrar hedefe yaklaşmıştır.

⑥ Kardiyak Cerrahi Sonrası Anemi ve Demir Eksikliği [Kaynak 8, 11]

Kardiyak cerrahi sonrası hastaların büyük çoğunluğunda en az hafif anemi görülür; genellikle mutlak veya fonksiyonel demir eksikliğiyle ilişkilidir. Ferritin <100 µg/L demir eksikliği için tanı ölçütüdür; güncel yaklaşım önce oral, yetersiz yanıtta intravenöz demir önerir. Bu hastada ferritin 19 µg/L, demir 15 µg/dL ile belirgin düşük olup MCV/RDW değişimi demir eksikliği anemisini desteklemektedir.

⑦ Ameliyat Sonrası Görüntüleme Takip Sıklığı [Kaynak 6]

AHA'nın kronik aort diseksiyonu görüntüleme takibi bilimsel açıklaması, cerrahi onarım sonrası 6. ve 12. ayda, sonrasında yıllık kontrol görüntülemesini önermektedir. Bu hastada ilk kontrol BT anjiyografisi ameliyattan ~10,6 hafta sonra yapılmış, sonraki ~4 ayda planlı bir aort BT anjiyografisi kaydına rastlanmamıştır; ~6,6 aylık süre dikkate alındığında 6-aylık kontrol görüntüleme zamanı gelmiştir.

8. Hekiminizle Görüşülmesi Önerilen Noktalar

Bu bölüm bir tanı veya tedavi talimatı değildir; yalnızca mevcut verilerden ortaya çıkan ve bir sonraki hekim kontrolünde gündeme getirilmesi faydalı olabilecek gözlemlerin özetidir.

1. Kronik demir eksikliği anemisi

Hemoglobin (9,7 g/dL), ferritin (19 µg/L) ve serum demiri (15 µg/dL) düşük;

MCV gerilemiş, RDW yükselmiştir. Demir replasman tedavisi ihtiyacının ve — warfarin+aspirin kullanımı göz önüne alınarak — olası gizli gastrointestinal kan kaybının araştırılıp araştırılmayacağının hekimle görüşülmesi önerilir.

2. Süregelen hafif enflamasyon ve yeni antibiyotik kürü

CRP referans üstü seyretmeye devam etmiş, 4 Eylül'de yeniden yükselmesi üzerine ampirik antibiyotik başlanmıştır. 10 Eylül'de kür tamamlandığında CRP'nin tekrar kontrolü ve gerekirse enfeksiyon kaynağının netleştirilmesi önerilir.

3. Lipid profilinde kötüleşme

Kolesterol (210 mg/dL) ve LDL (141 mg/dL) referans üstü, HDL (34 mg/dL) referans altıdır. Statin tedavisi ihtiyacının değerlendirilmesi hekimle görüşülebilir.

4. Aralıklı kan basıncı yükselmeleri

Dönemsel ortalamalar zaman zaman <120 mmHg hedefinin üzerine çıkmaktadır. Ağustos'ta eklenen Coversyl sonrası olumlu iyileşme izlenmekle birlikte, sürdürülebilirliğinin düzenli kontrollerde değerlendirilmesi önerilir.

5. 6 aylık kontrol aort BT anjiyografisi

Son kapsamlı kontrastlı aort görüntülemesi ~4,2 ay önce yapılmıştır. KVC/kardiyoloji ile 6-aylık kontrol BT anjiyografisinin planlanması için temasa geçilmesi önerilir.

6. Kanama bulgularına karşı farkındalık

Warfarin + aspirin birlikte kullanımı ve geçmişteki supratherapötik INR atağı

(8,46) göz önüne alındığında, dış eti kanaması, kolay morarma, siyah/katran renkli dışkı gibi bulguların hekime bildirilmesi önemlidir.

7. Tiroid fonksiyonunun izlenmesi

TSH değeri referans aralığının alt sınırına yaklaşmıştır (0,279). Ağır cerrahi/hastalık sonrası geçici olabilecek bu değer bir sonraki kontrolde tekrar değerlendirilmesi makul olacaktır.

9. Kaynakça (APA 7th Edition)

[1] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, ve ark. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2021;143(5):e72–e227.

[2] 2020 ACC/AHA Heart Valve Disease Guideline: Key Perspectives (Part 3). American College of Cardiology, acc.org.

[3] Ampatzidou F, Sileli M, Madesis A, ve ark. Predisposing factors for deep sternal wound infection after cardiac surgery. Crit Care. 2015;19(Suppl 1):P10.

[4] Kaul P. Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. J Cardiothorac Surg. 2017;12:94.

[5] Lau C, Gregg A, Ram E, ve ark. Long-term survival and operative outcomes of the Bentall procedure. J Thorac Cardiovasc Surg. 2025 (Weill Cornell Medicine, n=1.493).

[6] Fleischmann D, Afifi RO, Casanegra AI, ve ark. Imaging and Surveillance of Chronic Aortic Dissection: A Scientific Statement from the AHA. Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15(3):e000075.

[7] Melby SJ ve ark. (Washington University in St. Louis) — Aort diseksiyonu onarımı sonrası kan basıncı kontrolü ve geç reoperasyon riski ilişkisi.

[8] Venturini E, Iannuzzo G, Di Lorenzo A, ve ark. Short-term treatment of iron deficiency anemia after cardiac surgery. Int J Cardiol Heart Vasc. 2022;40:101038.

[9] Surgery for acute type A aortic dissection (derleme); Pittsburgh serisi ve IRAD verileri.

[10] Should patients on long-term warfarin take aspirin for heart disease? *Cleve Clin J Med.* 2008;75(3):206–208.

[11] Anemia and Iron Deficiency in Cardiac Surgery Patients: Prevalence, Implications, and Therapeutic Considerations (derleme, PMC).

10. Önemli Bilgilendirme ve Sorumluluk Reddi

Bu rapor, Klinik Takip uygulamasından dışa aktarılan hasta verilerinin klinik karar destek sistemi tarafından derlenmesi ve ilgili bilimsel literatürle karşılaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bir tıbbi tanı, tedavi planı veya reçete niteliği taşımaz; hekim muayenesinin ve klinik değerlendirmesinin yerini tutmaz. Rapordaki tüm bulgular ve öneriler, hastanın tedavisini yürüten hekimlerle birlikte değerlendirilmelidir. Literatür karşılaştırmaları genel popülasyon çalışmalarına dayanmaktadır ve bireysel hastaya doğrudan uygulanabilirliği hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Rapor oluşturulma tarihi: 09.09.2026 · Kaynak veri: Klinik Takip uygulaması tam veri dışa aktarımı · Klinik Karar Destek Konsültasyonu

Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., ... & Wojakowski, W. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561-632.

Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., ... & Kjeldsen, S. E. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874-2071.

Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.

Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024). EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.